

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS ONCOLÓGICOS

Validación de alcance con contraparte

Una síntesis para confirmar que comprendimos correctamente el problema, los procesos, las responsabilidades y el resultado esperado antes de continuar el desarrollo.

Propósito de esta reunión

Revisar las propuestas, registrar ajustes y acordar las decisiones necesarias para construir un producto operativo y verificable.

31 DE JULIO DE 2026

Documento para revisión clínica, operativa y administrativa. No contiene datos de pacientes ni reemplaza protocolos oficiales.

Lo que entendimos

La prioridad no es automatizar decisiones clínicas. Es construir una fuente de verdad operacional, actualizada y gobernada.

Situación actual

- Información distribuida entre PDF, Word, correos y notas.
- Dificultad para confirmar vigencia, estado y responsables.
- Slots, pretests y tareas dependen de coordinación manual.
- Los reportes no comparten todavía definiciones aprobadas.

Resultado del MVP

- Identificación de usuarios, centros, roles y permisos.
- Inventario y ciclo de vida de estudios.
- Selección y manejo de candidatos.
- Gestión de cupos, listas de espera y alertas.
- Arquitectura modular, APIs y documentación.

Qué podrá hacer un usuario autorizado

- Buscar estudios por patología, línea, biomarcador, centro y estado.
- Ver qué versión de protocolo está vigente, quién la confirmó y cuándo.
- Distinguir reclutamiento, seguimiento, hold, cierre y archivo.
- Gestionar oportunidades operativas sin emitir elegibilidad.
- Reconstruir cambios relevantes mediante auditoría.

Principio no negociable

La plataforma apoya la organización y la preselección administrativa. La elegibilidad final corresponde siempre al investigador principal y al equipo del estudio.

Las APIs prepararán una interoperabilidad gradual con sistemas autorizados. La conexión con ficha clínica u otras plataformas no forma parte del MVP mientras no exista una definición institucional específica.

Plan de ejecución

Mes 1

Levantamiento, requerimientos y flujo de procesos/arquitectura.

Mes 2

MVP funcional básico y validación con usuarios.

Mes 3

Puesta en marcha y marcha blanca.

Un ciclo de vida compartido

Proponemos separar el estado operativo del estudio de la disponibilidad de cupos o slots.

Preactivación Próximo a abrir; permite anticipar oportunidades.	Activo reclutando Abierto y buscando participantes.	Activo en seguimiento No recluta; mantiene participantes en control.
Hold Reclutamiento detenido temporalmente.	Cerrado Sin actividad operacional vigente.	Archivado Disponible únicamente para historia y trazabilidad.

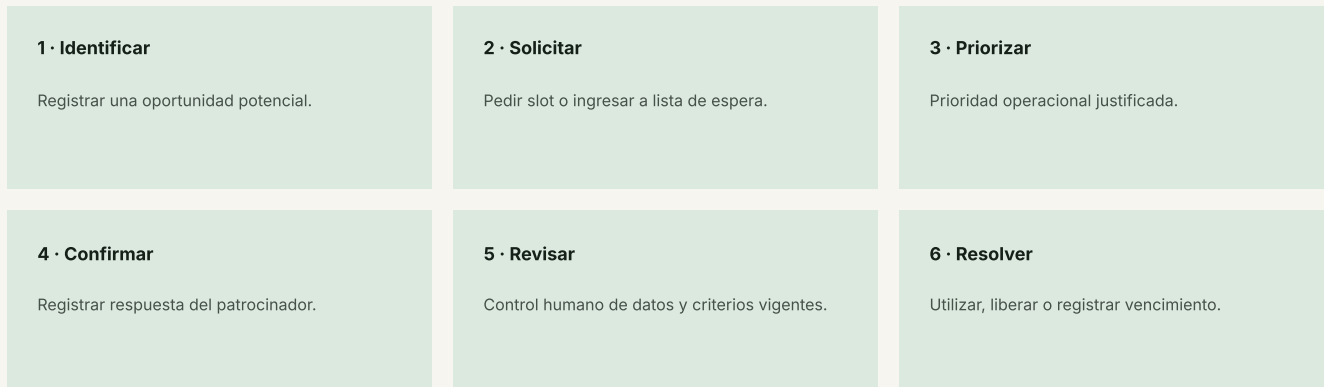
Información mínima propuesta

- Código, nombre y título oficial.
- Patrocinador, fase y diseño.
- Patología, escenario y línea.
- Cohortes, ramas y biomarcadores.
- Centro e investigador responsable.
- Coordinadora responsable.
- Estado operativo y disponibilidad.
- Versión vigente del protocolo.
- Fecha, fuente y responsable de verificación.
- Próxima fecha de revisión.

Necesitamos confirmar

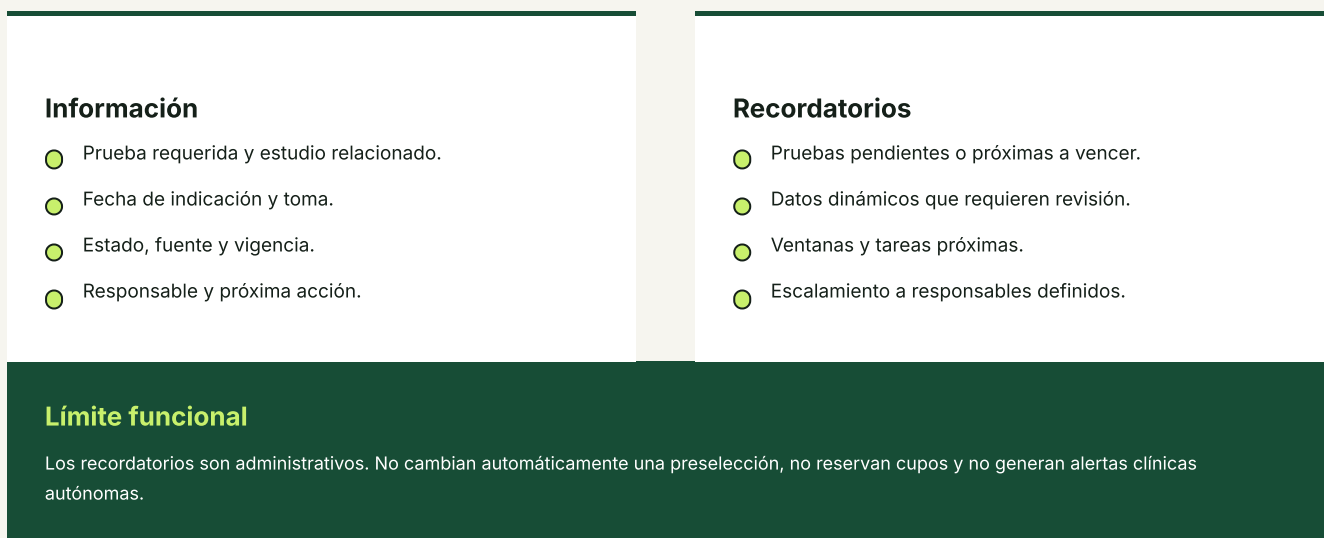
Quién mantiene cada estudio, quién reemplaza a esa persona, cada cuánto se revisa la información y cuándo debe mostrarse como desactualizada.

Flujo propuesto para slots



La lista de espera no constituye un ranking clínico. Todo movimiento debe conservar fecha, fuente, responsable y motivo.

Seguimiento propuesto para pretesting



Usuarios y responsabilidad

- Investigador principal.
- Médico investigador u oncólogo derivador.
- Enfermera coordinadora.
- Jefatura de enfermería.
- Coordinación administrativa.
- Factibilidad y preactivación.
- Administración técnica.
- Auditor autorizado.

Los permisos se definirán por centro, estudio, acción y relación con el recurso. Participar en una reunión o poseer un cargo no concede automáticamente acceso clínico.

Antes de utilizar datos reales

- Aprobar datos mínimos y fundamento o consentimiento aplicable.
- Definir permisos de visualización y modificación.
- Separar información identificatoria, clínica y operativa.
- Definir retención, eliminación y custodia documental.
- Aprobar descargas, exportaciones, auditoría y respuesta ante incidentes.

Fuera del MVP administrativo

Elegibilidad automática, extracción automática de protocolos y recomendaciones clínicas.

Audio en comités, integración con ficha clínica y mensajería externa.

Entorno inicial

Hasta que exista aprobación institucional, el desarrollo, las pruebas y las demostraciones utilizarán únicamente datos ficticios.

Roles propuestos para el tratamiento

La asignación debe formalizarse en el contrato y en un anexo de tratamiento de datos antes de operar con información real.

CICUC · Responsable de los datos

- Define finalidades, base de licitud y datos permitidos.
- Obtiene consentimientos o autorizaciones.
- Responde por procedencia, exactitud y conservación.
- Autoriza usuarios, integraciones y exportaciones.
- Gestiona derechos de titulares y decisiones clínicas.
- Custodia fichas y documentos fuente.

ADYAC · Encargado tecnológico

- Trata datos solo bajo instrucciones documentadas.
- Aplica seguridad proporcional al riesgo.
- Mantiene confidencialidad y mínimo privilegio.
- No usa los datos para finalidades propias.
- Informa incidentes y colabora en su investigación.
- Devuelve o elimina datos según instrucciones.

Asignación equilibrada

ADYAC no asumirá responsabilidad por la legalidad, procedencia o exactitud de datos seleccionados por CICUC, por instrucciones institucionales, por usos fuera del alcance ni por decisiones clínicas. ADYAC sí conserva responsabilidad por sus propios incumplimientos contractuales y deberes legales directos.

Protección buscada

Ninguna cláusula puede impedir que un tercero presente una reclamación. El objetivo es prevenir incidentes, documentar diligencia y asignar contractualmente quién responde por los riesgos que controla.

Revisión jurídica

Esta propuesta no reemplaza la revisión del contrato por abogados de CICUC y ADYAC.

Mecanismos recomendados

- Contrato con alcance, exclusiones, aceptación y control de cambios.
- Anexo de tratamiento de datos e instrucciones escritas.
- Anexo de seguridad, respaldo, accesos y vulnerabilidades.
- Matriz de responsabilidades ante solicitudes e incidentes.
- Autorización y obligaciones equivalentes para subencargados.
- Procedimiento de notificación y preservación de evidencia.
- Indemnidad recíproca según el riesgo controlado por cada parte.
- Límite de responsabilidad y exclusión de daños indirectos, con excepciones legales.
- Propiedad intelectual, licencias y software de terceros.
- Garantía de defectos separada de nuevas funcionalidades.
- Evaluación de seguros profesionales y de ciberseguridad.
- Escalamiento, negociación y solución de controversias.

Marco legal de referencia

Ley 19.628 / Ley 21.719	Protección de datos. La nueva regulación entra en vigor el 1 de diciembre de 2026 y distingue responsable y encargado.
Ley 20.584	La información clínica es sensible; regula custodia, acceso, confidencialidad e interoperabilidad.
Ley 21.663	Prevención, reporte y resolución de incidentes de ciberseguridad para instituciones alcanzadas.
Ley 17.336	Protege software y documentación; exige pactar por escrito la distribución de propiedad intelectual.
Código Civil, art. 1558	Permite acordar reglas de responsabilidad, con límites legales y sin garantizar inmunidad absoluta.

Antes de producción

No incorporar datos reales hasta aprobar contrato, anexo de tratamiento, controles de seguridad, responsables institucionales y procedimiento de incidentes.

Decisiones solicitadas

TEMA	PROPUESTA	VALIDACIÓN
Estados	Preactivación, reclutamiento, seguimiento, hold, cerrado y archivado.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Inventario	Coordinadora responsable, supervisión y fecha de próxima revisión.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Slots	Solicitud, espera, asignación, uso, liberación y vencimiento.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Pretesting	Tareas administrativas con fechas, vigencia y responsables.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Pacientes	Solo datos ficticios hasta aprobar privacidad y permisos.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Elegibilidad	Siempre corresponde al investigador y al equipo clínico.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
IA y voz	Fuera del MVP administrativo inicial.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Reportes	Implementar después de aprobar definiciones de KPI.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Responsabilidad	CICUC responsable de datos; ADYAC encargado bajo instrucciones.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Contrato de datos	Anexo de tratamiento y seguridad antes de producción.	☐ Aprobar ☐ Ajustar

Acuerdos y observaciones

Por CICUC

Nombre:

Cargo:

Firma y fecha:

Por el equipo del proyecto

Nombre:

Cargo:

Firma y fecha: